

# Gestante de 12 semanas con vómitos persistentes

Caso clínico de Obstetricia · Nivel: estudiante de grado · Código: OB-02

**Cómo usar este documento:** la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

## PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

### Datos de filiación

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nombre             | Lucía P. M.     |
| Edad               | 26 años         |
| Profesión          | Dependiente     |
| Estado civil       | Pareja de hecho |
| Fórmula obstétrica | G1 P0 A0        |
| Edad gestacional   | 11 + 5 semanas  |

### Motivo de consulta

Vómitos continuos desde hace 3 semanas; no tolera ni el agua y se encuentra muy débil.

### Antecedentes

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Personales         | Sin enfermedades. No alergias. No medicación habitual.           |
| Familiares         | Sin interés.                                                     |
| Gineco-obstétricos | Primer embarazo, deseado. Náuseas desde la semana 6, en aumento. |
| Hábitos            | No tabaco, no alcohol.                                           |

### Historia de la enfermedad actual

Náuseas continuas y vómitos hasta 8-10 veces al día, incluso en ayunas. En los últimos días no tolera líquidos. Ha perdido peso (refiere unos 4 kg, >5% de su peso). Refiere mareo al ponerse de pie, boca seca, orina escasa y oscura. No dolor abdominal localizado, no fiebre, no diarrea. No clínica miccional. No sangrado vaginal. Muy decaída y llorosa por la situación.

### Exploración física

TA 96/58 mmHg, FC 108 lpm. Afebril. Mucosas secas, signo del pliegue positivo, ojos hundidos. Peso actual con pérdida respecto al pregestacional. Abdomen blando, no doloroso, sin signos de irritación. Útero no palpable por encima de sínfisis. No focalidad.

### Pruebas complementarias disponibles

- Tira de orina: cetonuria +++, densidad elevada.
- Bioquímica: Na 132 mEq/L, K 3,1 mEq/L (hipopotasemia), Cl bajo. Función renal con leve elevación de urea.
- Gasometría venosa: tendencia a alcalosis metabólica hipoclorémica.
- Hemograma: leve hemoconcentración (Hto elevado).
- Perfil tiroideo: TSH ligeramente baja (hipertiroidismo bioquímico transitorio por hCG).

- Ecografía: gestación intraútero única, embrión con latido, acorde a 12 semanas (descarta enfermedad trofoblástica y gestación múltiple).

### Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Lucía, 26 años, embarazada de unas 12 semanas. Estás agotada y un poco asustada porque no puedes parar de vomitar y has perdido peso. Hablas de forma sencilla. No conoces palabras como "cetonuria". Si te preguntan, cuentas que casi no orinas y que la orina es oscura, que tienes la boca seca y mareo al levantarte. Te preocupa que esto le haga daño al bebé. Niegas dolor abdominal fuerte, fiebre o diarrea si te preguntan.

## PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

### Diagnóstico principal

Hiperémesis gravídica (vómitos del embarazo con pérdida de peso >5%, deshidratación, cetonuria y alteraciones hidroelectrolíticas).

### Diagnóstico diferencial

- Náuseas y vómitos leves del embarazo (sin deshidratación)
- Gastroenteritis aguda
- Enfermedad trofoblástica gestacional / gestación múltiple
- Pielonefritis
- Patología tiroidea primaria
- Pancreatitis/colestitis

### Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Cuantificar número de vómitos y pérdida de peso (>5%).
- Signos de deshidratación: oliguria, sed, mareo ortostático.
- Descartar otras causas: fiebre, diarrea, dolor focal, clínica miccional.
- Confirmar gestación y descartar mola/gemelar con ecografía.

### Pruebas que debería solicitar

- Tira de orina (cetonuria).
- Iones, función renal, gasometría venosa.
- Hemograma (hemoconcentración).
- Perfil tiroideo.
- Ecografía obstétrica.

### Manejo / tratamiento correcto

Ingreso si deshidratación/intolerancia oral. Sueroterapia IV con reposición de potasio y corrección de iones (evitar soluciones glucosadas como primera línea sin tiamina). Reposo digestivo y reintroducción progresiva. Antieméticos escalonados (doxilamina-piridoxina/vitamina B6; metoclopramida u ondansetrón según necesidad). Tiamina para prevenir encefalopatía de Wernicke si vómitos prolongados. Apoyo psicológico.

### Rúbrica de evaluación

| Criterio evaluado                                                               | Puntos     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reconoce signos de deshidratación y los explora (TA, FC, mucosas, ortostatismo) | 15         |
| Cuantifica pérdida de peso y la usa para el diagnóstico                         | 10         |
| Solicita iones + cetonuria + función renal                                      | 20         |
| Realiza/solicita ecografía para descartar mola y gemelar                        | 15         |
| Diagnostica hiperémesis gravídica (no simple náusea del embarazo)               | 15         |
| Maneja con sueroterapia + reposición de K + antieméticos + tiamina              | 25         |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>100</b> |

**Errores frecuentes / banderas rojas**

- Mandar a casa con antieméticos orales pese a la intolerancia y deshidratación.
- No reponer potasio (riesgo de arritmia).
- No descartar mola/gemelar con ecografía.
- Olvidar la tiamina en vómitos prolongados (riesgo de Wernicke).